

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 썬골이 튀어나오면 꼭 수술하나요?

아닙니다. 손상 단계와 통증·불안정성, 활동 요구를 함께 보고 보존적 치료부터 시행할 수 있습니다.

Q2 어깨 관절 탈구와 같은 건가요?

다릅니다. 상완골두는 제자리에 있고, 썬골과 견봉 사이의 AC 관절이 벌어진 손상입니다.

Q3 튀어나온 썬골은 다시 들어가나요?

통증과 기능이 좋아져도 돌출은 남을 수 있습니다. 모양만으로 수술 여부를 정하지 않습니다.

바로 진료가 필요한 신호

- 외상 뒤 심한 변형·부기와 함께 팔을 움직이기 어려움
- 팔·손이 저리거나 차갑고 창백해짐, 통증이 매우 심함

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

X-ray로 AC 관절과 오구쇄골 간격, 골절 여부를 확인하고 손상 단계·통증·활동 요구를 함께 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 어깨 관절경

진찰과 영상을 직접 설명하고 보존적 치료부터 관절 안정화·인대 재건까지 개인별 범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 X-ray·MRI·CT CD와 판독지
- 다친 날짜와 넘어지거나 부딪친 방향
- 통증·돌출·불안정감이 심해지는 동작

대표 전화 031-328-0333

용인특례시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사 결과에 따라 달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

견봉쇄골관절 탈구 (AC 관절)

넘어지며 어깨를 직접 부딪친 뒤 생긴 통증·돌출, 인대 손상과 관절 정렬을 함께 확인합니다.



오구쇄골인대 재건 및 관절 안정화

낮은 단계 손상은 보조기·냉찜질·재활로 회복하는 경우가 많습니다. 수술은 지속 증상과 불안정성, 활동 요구를 함께 보고 결정합니다.

01 질환·증상

견봉쇄골관절 탈구는 쇄골과 견봉을 잇는 인대가 늘어나거나 끊어진 손상입니다. 강한 외력에서는 오구쇄골인대까지 손상되어 쇄골 끝이 위로 돌출될 수 있습니다.



이런 증상을 확인합니다

- 어깨 위쪽의 국소 통증·부기·멍
- 쇄골 끝이 튀어나온 듯한 변형
- 팔을 들거나 가슴 쪽으로 모을 때 통증

진단의 핵심

진찰과 X-ray로 AC 관절 정렬·오구쇄골 간격·골절을 확인합니다. 필요하면 양측 비교 영상이나 CT·MRI로 동반 손상을 평가합니다.

02 치료 선택

손상 등급만으로 결정하지 않습니다. 통증·불안정성·기능, 직업·운동 요구와 회복 경과를 함께 보고 치료 방향을 정합니다.

먼저 하는 치료

- 보조기·냉찜질·진통제로 통증 조절
- 통증이 허용하는 범위에서 점진적 관절 운동
- 견갑골·회전근개 기능을 회복하는 재활

수술을 검토할 때

- 고도 전위·수평 불안정이 크고 기능 요구가 높을 때
- 충분한 비수술 치료 뒤에도 통증·불안정이 지속될 때
- 만성 불안정과 일상·운동 기능 제한이 뚜렷할 때

치료의 흐름

보조기·통증 조절



정렬·기능
재평가



재활 지속 또는
필요 시 수술

03 수술·회복

오구쇄골인대 재건 및 관절 안정화



- 가 AC 관절과 오구쇄골인대 손상, 수평·수직 불안정성을 확인
- 나 쇄골과 견봉의 정렬을 정상 범위로 맞춤
- 다 봉합 버튼·강한 실 또는 이식건으로 오구쇄골 간격을 안정화
- 라 AC 관절 정렬과 안정성을 확인하고 동반 손상을 치료

회복은 안정성과 기능에 맞춰

- 초기: 보조기·상처·통증 관리와 재건 부위 보호
- 중기: 지시에 따라 관절 운동과 견갑 안정화 운동
- 후기: X-ray·통증·가동 범위·근력 평가 후 복귀

알아둘 위험과 한계

감염, 신경·혈관 손상, 정복 소실, 고정물 자극·파손, 쇄골·오구돌기 골절, 관절 강직, 잔여 통증, 외상 후 관절염, 재수술 등이 있을 수 있습니다. 수술 법과 회복 일정은 환자마다 다릅니다.